



נוהל מס': 002.14
שם הנוהל: ניהול הריון משבוע 40 ולאחר המועד
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום:
	שם הנוהל: ניהול הריון משבוע 40 ולאחר המועד		מהדורה: 1
	כותב הנוהל: ד"ר צבי מילוא, פרופ' משנה קליני עידו שולט		תאריך עדכון: 10/6/2014
	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' זאב וינר, פרופ' אריה דרוגן, פרופ' משנה קליני עידו שולט	מאשר הנוהל: פרופ' זאב וינר	נספחים: ראה רשימת ספרות
	על החתום:	על החתום:	
מס' דפים: 5			

תוכן העניינים

העמוד

הנושא

- | | |
|---|-----------------------|
| 2 | 1. רקע |
| 3 | 2. מטרות הנוהל |
| 3 | 3. הגדרות ומונחים |
| 3 | 4. סמכות ואחריות |
| 4 | 5. עקרונות הנוהל |
| 4 | 6. דיווח ותיעוד |
| 5 | 7. סימוכין (אסמכתאות) |
| 5 | 8. נספחים |

1. רקע:

הריון שלאחר המועד (POSTTERM PREGNANCY) מוגדר כהריון הנמשך מעבר ל- 294 יום (42 שבועות) [1]. קביעה מדויקת של גיל ההריון חיונית לאבחנה. שכיחות הריון לאחר המועד הינה בין 3%-12%, מושפעת ממספר גורמים ובעיקר מהדיוק בקביעת גיל ההריון [1,2]. שכיחות הריון עודף עם תיארוך מדויק שנתמך בבדיקת על-קול בשליש הראשון הינה כ-2% [3]. רוב מקרי הריון שלאחר המועד הינם מסיבה לא ידועה. גורמי סיכון מוכרים הינם: מבכירה, הריון קודם שנסתיים בלידה לאחר המועד (סיכון פי 2-3), גורמים גנטיים אימהיים, עובר ממין זכר, והשמנת יתר [1,2].

סיכונים לעובר:

הסיכונים והסיבוכים בהריון שלאחר המועד הינם תהליכים הדרגתיים, המתרחשים החל מהמועד המשוער ללידה ושיעורם הולך ועולה עם התמשכות ההריון. סיבוכי הריון שלאחר המועד כוללים עלייה בשיעור התמותה הפרינטלית, עליה חדה מתוארת החל משבוע 40, כאשר בשבוע 42 נצפתה עליה של פי 2 בתמותה הפרינטלית בהשוואה לשבוע 40. הגורמים העיקריים לכך הינם תשניק (ASPHYXIA), שאיפת מקונים וזיהומים רחמיים. בנוסף קיימת עליה בשיעור המקרוזומיה, המביאה לעליה בשכיחות של לידה ממושכת, פרע כתפיים וסיבוכים אורטופדיים ונוירולוגיים [1-3,5-9].

תסמונת בשלות יתר (POSTMATURITY), המופיעה בכ-20% מההריונות העודפים מתארת מאפייני תת תזונה כרוניים, איבוד שומן תת-עורי ומסת שריר, דהידרציה וקילוף עור. נמצא גם סיכון מוגבר למיעוט מי שפיר שמתבטא בין היתר בניטור לא תקין, שאיפת מקונים וסיבוכים לאחר הלידה הכוללים היפוגליקמיה, פרכוסים, אי ספיקה נשימתית, כמו כן גם סיבוכים נוירולוגיים מאוחרים. הריון שלאחר המועד תואר כגורם סיכון בלתי תלוי לאנצפלופתיה שלאחר הלידה ולמוות בשנה הראשונה לחיי הילוד.

סיכונים לאם:

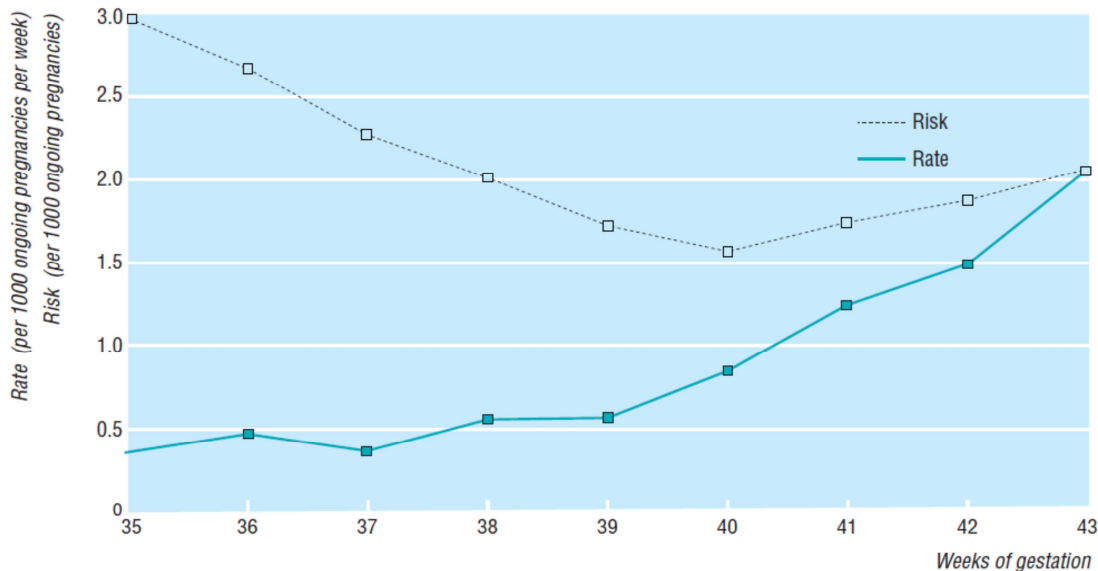
הסיבוכים לאם עולים גם הם בהדרגה משבוע 39 ואילך וכוללים עליה בשכיחות פרע לידה, עליה בשיעור מקרי כוריאמניוניטיס, עליה בשכיחות קרעים בדרגה 3-4 הקשורה למקרוזומיה, עלייה בשיעור לידה מכשירנית ועלייה בשיעור הניתוחים הקיסריים יחד עם סיכון יתר לסיבוכים כגון: זיהומים רחמיים, דימום ואירועים טרומבואמבולים [1-9].

מקובל לבצע ניטור טרום לידתי לאחר מועד הלידה המשוער, במטרה לאתר הריונות שבהם תהליכי בשלות היתר מתרחשים בקצב מואץ, ואשר בהם השראת לידה אפשר שתמנע סיבוכים.

נוהל מס': 002.14
שם הנוהל: ניהול הריון משבוע 40 ולאחר
המועד
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



תרשים 1:



Risk and rate of stillbirth according to gestational week (data from study by Cotzias et al)

Cotzias CS, Paterson-Brown S, Fisk NM. Prospective risk of unexplained stillbirth in singleton pregnancies at term: population based analysis. *BMJ* 1999;319:287-8. (31 July.)

2. מטרת הנוהל:

הגדרת הטיפול בהריון משב' 40 ולאחר המועד, משב' 42.

3. הגדרות ומונחים:

המונחים להגדרת הריון בסמוך למועד הינם:

Late preterm: 34 0/7 weeks of gestation through 36 6/7 weeks of gestation.

Early term: 37 0/7 weeks of gestation through 38 6/7 weeks of gestation.

Full term: 39 0/7 weeks of gestation through 40 6/7 weeks of gestation.

Late term: 41 0/7 weeks of gestation through 41 6/7 weeks of gestation.

Postterm: 42 0/7 weeks of gestation and beyond.

- Spong CY. Defining "term" pregnancy: recommendations from the Defining "Term" Pregnancy Workgroup. *JAMA* 2013;309:2445–6.
- Definition of term pregnancy. Committee Opinion No. 579. American College of Obstetricians and Gynecologists. *Obstet Gynecol* 2013;122;1139–40.

4. סמכות ואחריות:

ראה בכותרת המסמך.

נוהל מס': 002.14
שם הנוהל: ניהול הריון משבוע 40 ולאחר המועד
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

5. עקרונות הנוהל:

א. קביעת גיל ההריון:

ניתן לבצע בעזרת מספר נתונים: תאריך הווסת האחרון בנשים עם מחזור סדיר וספונטני, מועד הביוץ אם ידוע, בדיקת הריון (Beta-HCG) אם בוצעה עד שבוע ממועד הווסת החסר. בעקרון מומלץ להשתמש בבדיקת על-קול ועדיף ע"י מדידת CRL בשליש ראשון להריון [1] LEVEL A.

תיקון גיל ההריון יבוצע כאשר ההפרש בין גיל ההריון לפי וסת אחרון ולפי על-שמע הוא מעל:

1. שבוע במידה והעל-שמע בוצע עד שבוע 13 (CRL).
2. שבועיים במידה והעל-שמע בוצע בין שבוע 14 ל-20.

ב. סיווג היולדות לקבוצת הניטור או השראת הלידה בהתאם לקריטריונים הבאים (הריון בסיכון רגיל):

1. ניטור טרום לידתי:

ככלל מומלץ מעקב תנועות העובר ע"י המטופלת. בהריון הנמשך מעבר ל-287 יום (41 שבועות) מומלצת הערכת מצב העובר שתכלול מעקב אלקטרוני אחר דופק לב העובר ומעקב על-שמע אחר כמות מי השפיר. יש לבצע הערכה בתדירות של פעמיים בשבוע, כאמור לאחר שבוע 41 להריון. הערכה כזו מקטינה את הסיכונים לתמותה ותחלואה פרינטליים. LEVEL B [1,3,5,8,9].

2. השראת לידה:

- א. במידה וקיים סיכון למצבם התקין של האם או העובר יש ליילד LEVEL B [1-3,5-9].
 - ב. בהריון מעבר ל-280 יום (40 שבועות) ניתן להשרות לידה אם קיימים תנאים צוואריים המתאימים לכך. בהעדר תנאים צוואריים מתאימים ניתן לגרום להבשלת צוואר הרחם לצורך השראת לידה.
 - ג. עדיין ניתן להמתין ללידה ספונטנית עד שבוע 42 כיוון שהעלייה בסיכון אבסולוטי לסיבוכים השונים הינו נמוך ביותר LEVEL A.
 - במידה והוחלט על המתנה, מומלץ כאמור מעקב וניטור פעמיים בשבוע החל משבוע 41 להריון LEVE B [4,5,9].
 - ד. בהריון עודף מעבר ל-294 יום (42 שבועות) מומלצת השראת לידה [1-9]. ר'
- פרוטוקול השראת לידה).

6. דיווח ותיעוד:

החלטה על הפעלת לידה תתועד ברשומה הרפואית כולל באבחנות.

חריגה מפרוטוקול זה תדוין ברשומה הרפואית.

נוהל מס': 002.14
שם הנוהל: ניהול הריון משבוע 40 ולאחר המועד
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



7. סימוכין (אסמכתאות):

1. Management of postterm pregnancy. ACOG Practice Bulletin, Clinical management guidelines for obstetricians-gynecologists. Number 55, september 2004. Obstet Gynecol. Sep 2004;104(3): 639-646.
2. Doherty L, Norwitz Er. Prolonged pregnancy: when should we intervene? Curr Opin Obstet Gynecol. 2008; 20:519. 547.
3. Norwitz ER in UpToDate . Postterm pregnancy Last update Feb 2010 , Last literature review Jan 2011
4. Glmezoglu AM, Crowther CA, Middleton P. Induction of labor for improving birth outcome for women at or byond term. Cochrane Database Syst Rrv. Oct 18 2006; CD004945.
5. Siozos C, Stanley KP. Prolonged pregnancy. Current Obstetrics & gynecology 2005. 15:73.
6. Caughey AB, Sundaram V, Kaimal AJ, et al. Systematic review: Elective induction of labor versus expectant management of pregnancy. Ann Intern Med 2009; 151:252.
7. Nakling J, Backe B, Pregnancy risk increases from 41 weeks of gestation, Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:663,
8. Caughey AB , Butler JR in eMedicine Obstetrics and Gynecology : Postterm pregnancy. update :sep 13, 2010<http://emedicine.medscape.com/article/261369-overview>
9. Mandruzzato G, Alfirevitc Z, Chervenac F, et al . Guidelines for the management of postterm pregnancy. J. perinat. Med. 2010; 38:111-119.
10. Kaimal AJ, Little SE, Obido AO, et al Cost-effectiveness of elective induction of labor at 41 weeks in nulliparous women. Am. J. Obstet. Gynecol. 2011;204:e1-9.

8. נספחים:

ניירות עמדה, האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, נייר עמדה מספר 3, ניהול הריון שלאחר המועד, אושר ב-10/5/2011.

Gulmezoglu AM, Crowther CA, Middleton P, et al; Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jun 13;6:CD004945.

Management of postterm pregnancy. ACOG Practice Bulletin, Clinical management guidelines for obstetricians-gynecologists. Number 55, september 2004. Obstet Gynecol. Sep 2004;104(3): 639-646.

Induction of labour. RCOG, National Collaborating Centre for Women's and Children's Health Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence, July 2008.

Guidelines for the Management of Pregnancy at 41+0 to 42+0 Weeks. J Obstet Gynaecol Can 2008;30(9):800–810.